



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN KERJA
KOMITE PENINGKATAN MUTU DAN
KESELAMATAN PASIEN
TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 004.6/I-PDM/KMKP/I/2026

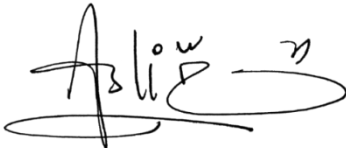
Tentang
Pedoman Kerja Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

Disusun oleh :
Ketua Komite PMKP



(dr. Ari Putriani, Sp. PK)

Disetujui oleh:
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes AFP)

Ditetapkan oleh:
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Resti Lestantini, M.Kes)



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 004.6/I-PDM/KMKP/I/2026**

TENTANG

**PEDOMAN PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN
DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kualitas pelayanan kesehatan perlu mengatur Rumah Sakit dengan Peraturan;
- b. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 097.3/I-PDM/KMKP/I/2022 tentang Pedoman Peningkatan Mutu dan keselamatan pasien perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan di rumah sakit, sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit tentang Pedoman Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Tranfusi Darah ;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 25 tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;
9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPMI-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG
PEDOMAN KERJA PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Peningkatan Mutu adalah pendekatan pembelajaran dan perbaikan terus menerus pada proses pemberian pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan pasien dan pihak pihak yang berkepentingan lainnya, yang dilaksanakan secara komprehensif dan integratif.
- 2) Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan



pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindaklanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil

- 3) Insiden keselamatan pasien yang selanjutnya disebut insiden, adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien
- 4) Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat mempengaruhi keselamatan pasien, petugas, dan mutu pelayanan di rumah sakit.

Pasal 2

- 1) Ruang lingkup Peraturan Direktur ini meliputi pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien ke semua unit di seluruh area dalam rumah sakit
- 2) Pelaksanaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit melalui penerapan manajemen risiko dalam seluruh aspek pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit

Pasal 3

Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang bertanggungjawab penuh terhadap peningkatan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada Malang.

Pasal 4

Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang membentuk Komite PMKP.

Pasal 5

Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang memilih dan menetapkan layanan klinis prioritas.

Pasal 6

Direktur bersama Komite Mutu menyusun program mutu dan keselamatan pasien, melaksanakan, melakukan monitoring dan mengevaluasi kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada Malang.

Pasal 7

Komite Mutu melakukan evaluasi mutu rumah sakit melalui indikator mutu rumah sakit.

Pasal 8

Ruang lingkup kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien meliputi seluruh unit yang ada di Rumah Sakit Prima Husada Malang .

Pasal 9

Komite Mutu melakukan evaluasi mutu rumah sakit melalui monitoring capaian indikator mutu rumah sakit.



Pasal 10

Indikator mutu rumah sakit terdiri dari indikator mutu prioritas rumah sakit, indikator mutu nasional, indikator mutu prioritas unit, indikator mutu kontrak, indikator mutu terkait penilaian kinerja.

Pasal 11

Penetapan indikator mutu prioritas rumah sakit dilakukan melalui rapat yang dipimpin oleh Direktur Utama, bersama - sama dengan Direksi yang lain, para Kepala Bidang, dan Komite Mutu, mengacu pada antara lain rencana strategis rumah sakit, layanan unggulan rumah sakit, proses layanan yang high risk, high volume maupun problem prone.

Pasal 12

Hasil sensus indikator mutu prioritas rumah sakit dikumpulkan oleh unit terkait, dimonitoring dan dievaluasi oleh Komite Mutu.

Pasal 13

Validasi data dilakukan apabila : terdapat indikator mutu baru, data akan diumumkan ke publik, cara pengumpulan data berubah, ditemukan adanya perubahan data tanpa alasan yang jelas, sumber data berubah, atau subyek dari pengumpulan data berubah. Validasi dilakukan dengan mengumpulkan data ulang oleh orang yang berbeda.

Pasal 14

Penetapan indikator mutu prioritas unit dilakukan melalui rapat unit bersama dengan Komite Mutu, dan mengacu pada proses layanan yang masih menjadi masalah di unit, sehingga butuh perbaikan dan mengacu juga pada risiko - risiko yang selama ini ditemukan di unit.

Pasal 15

Indikator mutu unit dikelola dan dianalisa oleh unit yang bersangkutan, dilaporkan kepada Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai bagian dari laporan bulanan unit dengan tembusan kepada Kepala Bidang masing - masing, dan kepada Komite Mutu.

Pasal 16

Hasil capaian indikator mutu rumah sakit dan indikator mutu unit, diinformasikan secara periodik (setiap semester) kepada seluruh staf rumah sakit melalui jaringan intranet rumah sakit dan diinformasikan ke publik secara periodik (setiap semester) melalui web site rumah sakit.

Pasal 17

Komite Mutu melakukan evaluasi mutu kinerja unit melalui monitoring capaian indikator mutu unit.

Pasal 18

Komite Mutu terlibat dalam penilaian kinerja individu dengan memberikan pertimbangan rekomendasi kepada pimpinan rumah sakit terkait kegiatan mutu dan keselamatan pasien melalui bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 19

Komite Mutu bekerjasama dengan Komite Medis dalam



mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan menggunakan pedoman klinis dan Clinical Pathway atau protokol klinis yang sesuai dengan kondisi Rumah Sakit Prima Husada Malang.

Pasal 20

Clinical Pathway yang dipilih di Rumah Sakit Prima Husada Malang ditetapkan berdasarkan layanan kasus/tindakan yang dinilai mempunyai risiko tinggi, variasi kasus lebar maupun kasus/tindakan yang membutuhkan biaya/sumber daya besar.

Pasal 21

Komite Mutu bertanggung jawab dan melakukan monitoring terhadap implementasi 6 sasaran keselamatan pasien di semua unit di Rumah Sakit, yang meliputi :

- a. Mengidentifikasi Pasien dengan benar
- b. Meningkatkan komunikasi efektif
- c. Meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai
- d. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi
- e. Mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan
- f. Mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh

Pasal 22

Subkomit mengelola insiden keselamatan pasien, yang terdiri dari:

- a. Kondisi Potensial Cedera Signifikan (KPCS)
- b. Kejadian Nyaris Cedera (KNC)
- c. Kejadian Tidak Cedera (KTC)
- d. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan
- e. Kejadian Sentinel

Pasal 23

Komite Mutu melakukan analisa, dan jika diperlukan melakukan grading ulang terhadap laporan insiden keselamatan pasien.

Pasal 24

Peraturan Direktur Utama RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 03 Januari 2026
PLT Direktur Rumah Sakit
Prima Husada Malang,



dr. Resti Lestantini, M.Kes



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat yang telah dikaruniakan kepada penyusun, sehingga Pedoman Kerja Komite Mutu RS Prima Husada Malang Tahun 2026 ini dapat selesai disusun.

Pedoman Kerja Komite Peningkatan Mutu Dan Keselamatan Pasien RS Prima Husada Malang ini merupakan pegangan bagi Komite Mutu dalam mengimplementasikan maupun melaksanakan kegiatan- kegiatan dalam usaha peningkatan mutu dan keselamatan pasien di RS Prima Husada Malang.

Tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kerjasama dan bantuan semua pihak dalam menyelesaikan penyusunan Pedoman Kerja Komite Mutu Tahun 2026.

Malang , 03 Januari 2026
RS Prima Husada Malang

Penyusun



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR UTAMARS
PRIMA HUSADA MALANG NOMOR
004.6/I-PDM/KMKP/I/2026
TENTANG
PEDOMAN KERJA KOMITE MUTU

PEDOMAN KERJA KOMITE MUTU TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat pakar dan padat modal. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan di rumah sakit menyangkut berbagai fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian, serta mencakup berbagai tingkatan maupun jenis disiplin. Agar rumah sakit harus memiliki sumber daya manusia yang profesional baik di bidang teknis medis maupun administrasi kesehatan. Untuk menjaga dan meningkatkan mutu, rumah sakit harus mempunyai suatu ukuran yang menjamin peningkatan mutu dan keselamatan pasien di semua tingkatan.

Mutu, tidak akan tercapai tanpa suatu perencanaan dan wawasan yang terkait dengan mutu tersebut. Bila kita menginginkan pelayanan yang bermutu di Rumah Sakit, maka pimpinan dan manajemen rumah sakit perlu memperluas wawasan mengenai mutu pelayanan dan merencanakan serangkaian aksi untuk mencapai suatu tingkat/ standard tertentu.

Suatu pelayanan dikatakan bermutu dalam dimensi tertentu, bila indikator pelayanan mencapai atau melampaui suatu standard tertentu. Indikator mutu pelayanan rumah sakit akan memiliki manfaat yang sangat banyak bagi pihak pengelola rumah sakit, karena dapat digunakan sebagai alat melaksanakan manajemen kontrol, alat untuk mendukung pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan kegiatan untuk masa yang akan datang dan dapat pula digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja rumah sakit sendiri (*self assesment*). Maka dari itu, indikator mutu perlu dirancang dengan seksama dengan mempertimbangkan dimensi mutu yang ingin diukur, cara pengumpulan data, dan strategi analisisnya.

1.2 Tujuan Pedoman

Pelayanan yang berkualitas merupakan cerminan dari sebuah proses yang berkesinambungan dan berorientasi pada hasil yang memuaskan. Dalam perkembangan masyarakat yang semakin kritis, mutu pelayanan rumah sakit tidak hanya disorot dari aspek klinis medisnya saja namun juga dari aspek keselamatan pasien dan aspek pemberian pelayanannya, karena muara dari pelayanan rumah sakit adalah pelayanan jasa.

Peningkatan mutu adalah program yang disusun secara tersandar, objektif dan sistematis dengan memantau dan menilai, untuk meningkatkan asuhan pasien dan memecahkan masalah-masalah yang terungkap. Sedangkan keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.

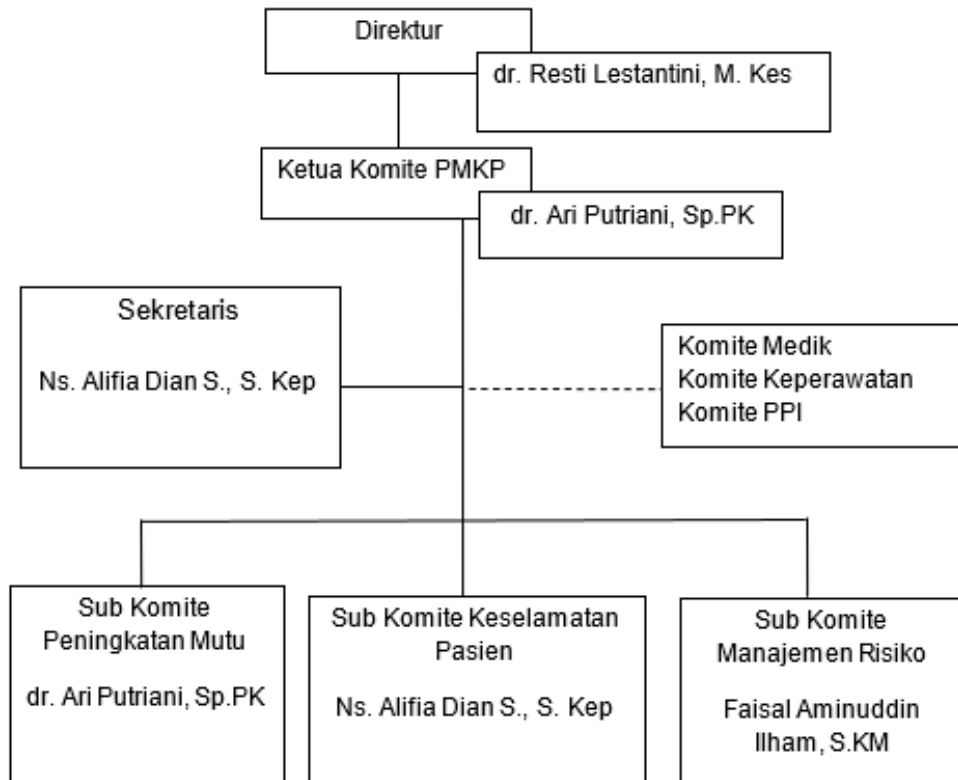


Oleh karena itu, untuk senantiasa mempertahankan dan meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di RS Prima Husada Malang, Pedoman Komite Mutu ini disusun sebagai pedoman kerja dan acuan bagi komite untuk melaksanakan kegiatan.



BAB II PENGORGANISASIAN

2.1 Struktur Organisasi Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien



2.2 Uraian Tugas dan Wewenang

a. Direktur Rumah Sakit

Tugas Direktur Rumah Sakit :

1. Membentuk Komite dan Tim PMKP dengan Surat Keputusan
2. Bertanggung jawab dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap peningkatan mutu dan keselamatan pasien
3. Bertanggung jawab terhadap tersedianya fasilitas sarana dan prasarana termasuk anggaran yang dibutuhkan
4. Menentukan kebijakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien
5. Mengadakan evaluasi kebijakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien berdasarkan saran dari Tim PMKP
6. Mengesahkan Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk PMKP

b. Komite PMKP

Kriteria Anggota Komite PMKP :

1. Mempunyai minat dalam PMKP
2. Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan PMKP

Tugas dan Tanggung Jawab Komite PMKP :

1. Sebagai motor penggerak penyusunan program PMKP rumah sakit
2. Melakukan monitoring dan memandu penerapan program PMKP di unit kerja
3. Membantu dan melakukan koordinasi dengan pimpinan unit pelayanan dalam memilih prioritas perbaikan, pengukuran mutu/indikator mutu, dan menindak lanjut hasil capaian indikator



4. Melakukan koordinasi dan pengorganisasian pemilihan prioritas program di tingkat unit kerja serta menggabungkan menjadi prioritas rumah sakit secara keseluruhan. Prioritas program rumah sakit ini harus terkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaannya
 5. Menentukan profil indikator mutu, metode analisis, dan validasi data dari data indikator mutu yang dikumpulkan dari seluruh unit kerja di rumah sakit
 6. Menyusun formulir untuk mengumpulkan data, menentukan jenis data, serta bagaimana alur data dan pelaporan dilaksanakan
 7. Menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait serta menyampaikan masalah terkait pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien
 8. Terlibat secara penuh dalam kegiatan Pendidikan dan pelatihan PMKP
 9. Bertanggung jawab untuk mengomunikasikan masalah-masalah mutu secara rutin kepada semua staf
 10. Menyusun regulasi terkait dengan pengawasan dan penetapan program PMKP
 11. Menangani insiden keselamatan pasien yang meliputi pelaporan, verifikasi, investigasi, dan analisis penyebab insiden keselamatan pasien
 12. Mengkoordinasikan penyusunan program manajemen risiko rumah sakit
- c. Sarana dan Fasilitas Pelayanan Penunjang (Supporting System)
- Sarana Kesekretariatan
1. Ruang sekretariat dan tenaga sekretaris yang *full time*.
 2. Komputer, printer, dan internet.
 3. Telepon
 4. Alat tulis kantor.
- d. Dukungan Manajemen
- Dukungan yang diberikan oleh manajemen berupa:
1. Penerbitan Surat Keputusan untuk Komite dan Tim PMKP
 2. Anggaran atau dana untuk kegiatan:
 - a) Pendidikan atau Pelatihan (diklat)
 - b) Pengadaan fasilitas pelayanan penunjang.
 - c) Untuk pelaksanaan program, monitoring, evaluasi, laporan, dan rapat rutin.
 - d) Intensif/Tunjangan/Reward untuk Tim PMKP
- e. Organisasi
- Kriteria
1. Ketua Komite PMKP
 - a) Dokter/Dokter spesialis memiliki sertifikat pelatihan PMKP
 - b) Memiliki komitmen di bidang peningkatan mutu dan keselamatan pasien
 - c) Memiliki kemampuan leadership
 2. Sub Komite Peningkatan Mutu
 - a) Dokter/Perawat memiliki sertifikat pelatihan PMKP
 - b) Memiliki komitmen di bidang peningkatan mutu dan keselamatan pasien
 3. Sub Komite Keselamatan Pasien dan PPK CP
 - a) Dokter /Perawat memiliki sertifikat pelatihan PMKP
 - b) Memiliki komitmen di bidang peningkatan mutu dan keselamatan pasien
 4. Sub Komite Manajemen Risiko
 - a) Dokter/Perawat memiliki sertifikat pelatihan PMKP
 - b) Memiliki komitmen di bidang peningkatan mutu dan keselamatan pasien



5. Sekretaris

- a) Perawat memiliki sertifikat pelatihan PMKP
- b) Memiliki komitmen di bidang peningkatan mutu dan keselamatan pasien

6. Anggota

- a) Tenaga kesehatan maupun non tenaga kesehatan memiliki sertifikat pelatihan PMKP
- b) Memiliki komitmen di bidang peningkatan mutu dan keselamatan pasien

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Ketua

a. Tugas

- 1) Menyusun dan merencanakan pelaksanaan kegiatan program kerja PMKP
- 2) Memimpin, mengkoordinir, dan mengevaluasi pelaksanaan operasional PMKP secara efektif, efisien dan bermutu
- 3) Mengumpulkan data indikator baik dari Koordinator Peningkatan Mutu maupun dari Koordinator Keselamatan Pasien RS dan unit kerja terkait
- 4) Menganalisa data indikator mutu pelayanan baik indikator mutu klinis RS maupun indikator mutu manajerial RS serta indikator keselamatan pasien
- 5) Melaksanakan analisis terhadap data yang dikumpulkan dan diubah menjadi informasi
- 6) Melakukan validasi data PMKP secara internal dan dilakukan secara periodik
- 7) Menyebarkan informasi tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara regular melalui rapat staf
- 8) Meningkatkan pengetahuan anggota dengan memberikan pelatihan terhadap staf yang ikut serta dalam program PMKP

b. Tanggung jawab

- 1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit
- 2) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan mutu dan keselamatan pasien
- 3) Bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien kepada Direktur RS Prima Husada
- 4) Bertanggung jawab terhadap ketersediaan data dan informasi yang berhubungan dengan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit
- 5) Bertanggung jawab dalam pemberian informasi yang berhubungan dengan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit
- 6) Bertanggung jawab terhadap disiplin dan kinerja kerja staf di Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

2. Sub Komite peningkatan Mutu

a. Tugas

- 1) Melaksanakan kegiatan program peningkatan mutu di RS Prima Husada
- 2) Menyusun panduan indikator mutu
- 3) Membuat metode pemantauan indikator mutu klinis dan manajerial
- 4) Menyusun formulir pemantauan indikator mutu
- 5) Berkoordinasi dengan unit terkait dalam penyelenggaraan pemantauan indikator mutu
- 6) Menganalisa hasil pencapaian indikator mutu
- 7) Membuat laporan periodik hasil pemantauan indikator mutu



- 8) Melakukan perbandingan hasil pemantauan indikator mutu secara periodik dengan standar nasional serta rumah sakit lain yang sejenis
- 9) Melaksanakan komunikasi secara internal dan eksternal tentang pencapaian mutu kepada unit kerja di lingkungan dan pihak luar melalui surat tertulis, email dan telepon
- 10) Membantu berkoordinasi dalam kegiatan internal dan eksternal program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
- 11) Menyusun panduan pelaksanaan validasi data internal khusus indikator mutu
- 12) Membuat alat ukur validasi khusus indikator mutu
- 13) Menyelenggarakan kegiatan validasi hasil pencapaian indikator mutu berkoordinasi dengan unit terkait
- 14) Melaksanakan analisis komparatif hasil validasi internal dengan data unit terkait
- 15) Membuat laporan hasil validasi internal khusus indikator mutu
- 16) Berkoordinasi dengan Kepala Bagian Perencanaan dan Informasi dalam mengunggah hasil pencapaian indikator mutu yang telah dinyatakan valid dan direkomendasi oleh Direktur

b. Tanggung Jawab

- 1) Bertanggung jawab terhadap pemantauan Program Indikator Mutu
- 2) Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan pemantauan indikator mutu di Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
- 3) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan inovasi mutu dan Manajemen resiko di rumah sakit
- 4) Bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan indikator mutu serta kegiatan-kegiatan mutu lainnya kepada Ketua Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
- 5) Bertanggung jawab terhadap pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan mutu
- 6) Bertanggung jawab terhadap pemantauan indikator mutu unit kerja
- 7) Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan pemantauan mutu unit kerja
- 8) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan mutu rumah sakit
- 9) Bertanggung jawab dalam pemberian informasi yang berhubungan dengan kegiatan mutu rumah sakit

3. Sub Komite Keselamatan Pasien dan PPK CP

a. Tugas

- 1) Berkoordinasi dengan unit terkait dalam pelaksanaan clinical pathway
- 2) Melaksanakan komunikasi secara internal dan eksternal tentang pelaksanaan clinical pathway kepada unit kerja di lingkungan dan pihak luar melalui surat tertulis, email, dan telepon
- 3) Mengevaluasi pelaksanaan 5 (lima) area prioritas yang sudah ditetapkan oleh Direktur dengan fokus utama pada penggunaan PPK, clinical pathway

b. Tanggung jawab

- 1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan clinical pathway
- 2) Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan pelaksanaan clinical pathway di Komite peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien



- 3) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan inovasi mutu dan pelaksanaan clinical pathway dan Manajemen resiko di rumah sakit
- 4) Bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan indikator mutu dan pelaksanaan clinical pathway
- 5) Bertanggung jawab terhadap pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan clinical pathway rumah sakit

4. Sub Komite Manajemen Risiko

a. Tugas

- 1) Melakukan monitoring perencanaan risk manajemen
- 2) Melakukan monitoring pelaksanaan program
- 3) Melakukan pendidikan/edukasi staf tentang manajemen risiko rumah sakit
- 4) Monitoring insiden/ kecelakaan fasilitas

b. Tanggung jawab

- 1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan manajemen risiko
- 2) Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan pelaksanaan manajemen risiko
- 3) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Manajemen resiko di rumah sakit
- 4) Bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan manajemen risiko
- 5) Bertanggung jawab terhadap pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan manajemen risiko

5. Sekretaris

a. Tugas

- 1) Mengatur rapat dan jadwal rapat Komite PMKP
- 2) Menyiapkan ruang rapat dan perlengkapan yang diperlukan
- 3) Membantu meminta laporan indikator kepada unit kerja terkait
- 4) Menganalisis data PMKP bersama ketua dan anggota Komite PMKP
- 5) Mendokumentasikan hasil pencapaian indikator area klinis, manajerial dan indikator sasaran keselamatan pasien
- 6) Menjadi notulen di setiap kegiatan pertemuan Komite PMKP
- 7) Mengorganisir kebutuhan logistik Komite PMKP
- 8) Membantu berkoordinasi dalam kegiatan internal dan eksternal Komite PMKP
- 9) Mengerjakan tugas – tugas administratif dan kesekretariatan lainnya

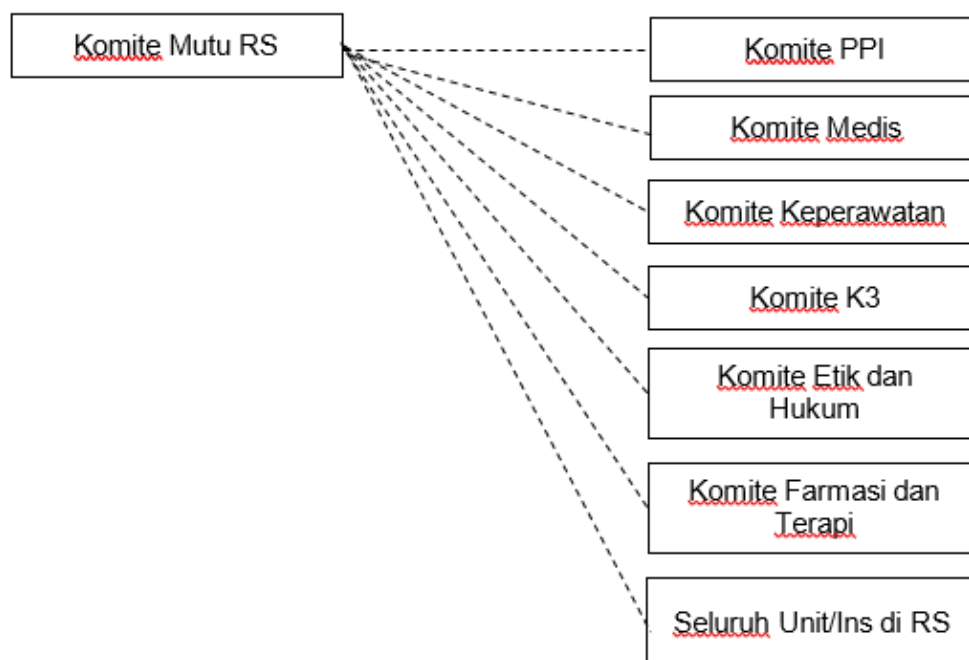
b. Tanggung jawab

- 1) Bertanggung jawab terhadap kegiatan administratif di Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
- 2) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan mutu dan keselamatan pasien
- 3) Bertanggung jawab melaporkan hasil kegiatan administratif kepada Ketua Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien



- Tentang Staf Organisasi
Anggota Komite PMKP terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan dan tenaga non Kesehatan
- Dukungan/Kebijakan Manajemen
Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional yang perlu dipersiapkan oleh rumah sakit adalah:
 - a. SPO Penginputan data mutu
 - b. SPO validasi data mutu
- Pengembangan dan Pendidikan
 - 1. Komite PMKP
 - a. Wajib memiliki pendidikan dan pelatihan dasar dan lanjut PMKP
 - b. Memiliki sertifikat PMKP
 - c. Mengembangkan diri mengikuti seminar, lokakarya, dan sejenisnya.
 - d. Bimbingan teknis secara berkesinambungan
 - 2. Staf Rumah Sakit
 - a. Semua staf rumah sakit harus mengetahui prinsip-prinsip peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
 - b. Semua staf rumah sakit yang berhubungan dengan mutu harus mengikuti pelatihan PMKP.
 - c. Rumah sakit secara berkala melakukan sosialisasi/simulasi PMKP
 - d. Semua karyawan baru harus mendapatkan orientasi PMKP.

2.3 Tata Hubungan Kerja





- a. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
 1. Tata hubungan kerja dalam penerapan peningkatan mutu RS
 - a) Setiap bulannya, Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi melaporkan hasil capaian indikator-indikator PPI kepada Komite Mutu, khususnya Sub Komite Mutu, dimana indikator-indikator PPI ini sangat terkait dan dapat menjadi cerminan mutu kualitas pelayanan rumah sakit dan sangat mempengaruhi keselamatan pasien selama dirawat di rumah sakit.
 - b) Hasil capaian indikator-indikator PPI, kejadian HAIs dan seluruh risiko infeksi di rumah sakit akan dibahas bersama dengan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dalam rapat Komite Mutu yang dilaksanakan setiap 3 bulan.
 2. Tata hubungan kerja dalam penerapan keselamatan pasien
Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi melaporkan adanya kejadian HAIs (*Healthcare Associated Infections*) sebagai insiden keselamatan pasien dan berkoordinasi dengan Komite Mutu, khususnya Sub Komite Keselamatan Pasien, untuk melakukan investigasi atas insiden tersebut.
 3. Tata hubungan kerja dalam penerapan manajemen risiko
Terkait dengan ICRA (*Infection Control Risk Assesmen*), Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi juga melakukan koordinasi dengan Komite Mutu, khususnya dengan Sub Komite Manajemen Risiko, untuk pengendalian risiko infeksi terkait dengan mutu pelayanan terhadap pasien (*patient care related risks*).
- b. Komite Medis
 1. Tata hubungan kerja dalam penerapan peningkatan mutu RS
 - a) Komite Mutu bekerjasama dengan Komite Medis dalam penerapan Panduan Praktik Klinik (PPK) dan Clinical Pathway (CP) dalam upaya mencapai standarisasi asuhan klinis dan mengurangi kondisi variasi pelayanan, sekaligus tercapainya kendali mutu dan kendali biaya melalui penerapan CP di 5 area prioritas layanan. Evaluasi pelaksanaan CP dilakukan per bulan oleh Komite Mutu, dan hasil evaluasi disampaikan kepada Komite Medis sebagai masukan untuk perbaikan selanjutnya.
 - b) Komite Mutu berkoordinasi dengan Komite Medis dalam penentuan indikator mutu terkait penilaian kinerja tenaga medis di Rumah Sakit, dan Komite Mutu menyerahkan hasil indikator mutu sebagai bagian penilaian kinerja kepada Komite Medis
 2. Tata hubungan kerja dalam penerapan keselamatan pasien
Komite Mutu melakukan koordinasi dengan Komite Medis terkait insiden keselamatan pasien, mulai dari pelaporan, analisa akar masalah, hingga tindak lanjut terkait insiden keselamatan pasien.
 3. Tata hubungan kerja dalam penerapan manajemen risiko
Komite Mutu melakukan koordinasi dengan Komite Medis terkait manajemen risiko di RS yang berhubungan dengan tenaga medis
- c. Komite Keperawatan
 1. Tata hubungan kerja dalam penerapan peningkatan mutu RS
 - a) Komite Mutu bekerjasama dengan Komite Keperawatan dalam penerapan Panduan Asuhan Keperawatan (PAK) dan Clinical Pathway (CP) dalam upaya mencapai standarisasi asuhan keperawatan, sekaligus tercapainya kendali mutu dan kendali biaya melalui penerapan CP di 5 area prioritas layanan. Evaluasi pelaksanaan CP dilakukan per bulan oleh Komite Mutu, dan hasil evaluasi disampaikan kepada Komite Keperawatan sebagai masukan untuk perbaikan selanjutnya.
 - b) Komite Mutu berkoordinasi dengan Komite Keperawatan dalam penentuan indikator mutu terkait penilaian kinerja keperawatan di Rumah Sakit, dan Komite Mutu menyerahkan hasil indikator mutu sebagai bagian penilaian kinerja kepada Komite Keperawatan.



2. Tata hubungan kerja dalam penerapan keselamatan pasien
Komite Mutu melakukan koordinasi dengan Komite Keperawatan terkait insiden keselamatan pasien, mulai dari pelaporan, analisa akar masalah, hingga tindak lanjut terkait insiden keselamatan pasien.
 3. Tata hubungan kerja dalam penerapan manajemen risiko
Komite Mutu melakukan koordinasi dengan Komite Keperawatan terkait manajemen risiko di RS yang berhubungan dengan tenaga keperawatan.
- d. Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
1. Tata hubungan kerja dalam penerapan peningkatan mutu RS
Komite Mutu berkoordinasi dengan Komite K3 terkait dengan penilaian mutu K3 yang digunakan untuk evaluasi pelaksanaan K3 di lingkungan Rumah Sakit
 2. Tata hubungan kerja dalam penerapan manajemen risiko
Komite Mutu bekerjasama dengan Komite K3 dalam mengelola risiko yang berhubungan dengan karyawan (*employee related risks*), yang meliputi :
 - a) Risiko keselamatan dan kesehatan kerja
 - b) Keamanan lingkungan kerja dan kesehatan tenaga kerja
 - c) Pengurangan risiko penyakit / cedera akibat kerja
 - d) Penatalaksanaan dan kompensasi bagi tenaga kerja terkait risiko penyakit / cedera akibat kerja
- e. Komite Etik dan Hukum
1. Tata hubungan kerja dalam penerapan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di RS
Komite Mutu bekerjasama dengan Komite Etik dan Hukum dalam usaha meningkatkan dan menyelenggarakan budaya keselamatan di Rumah Sakit Prima Husada Malang. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan budaya keselamatan adalah melakukan pendidikan dan pelatihan terkait budaya keselamatan, menetapkan alur pelaporan insiden budaya keselamatan, menindaklanjuti laporan insiden budaya keselamatan, melakukan survey budaya keselamatan dan menetapkan tindak lanjut dari hasil survey tersebut.
 2. Tata hubungan kerja dalam penerapan manajemen risiko
Komite Mutu melakukan koordinasi dengan Komite Etik dan Hukum terkait manajemen risiko di RS yang berhubungan dengan pelanggaran etik dan hukum di Rumah Sakit.
- f. Farmasi dan Terapi
1. Tata hubungan kerja dalam penerapan peningkatan mutu RS
Komite Mutu berkoordinasi dengan Komite Farmasi dan Terapi terkait dengan penilaian mutu yang digunakan untuk evaluasi pelaksanaan pemberian pelayanan farmasi dan terapi di lingkungan Rumah Sakit
- g. Tata hubungan kerja dalam penerapan keselamatan pasien
Komite Mutu melakukan koordinasi dengan Komite Farmasi dan Terapi terkait insiden keselamatan pasien, mulai dari pelaporan, analisa akar masalah, hingga tindak lanjut terkait insiden keselamatan pasien.
- h. Tata hubungan kerja dalam penerapan manajemen risiko
Komite Mutu melakukan koordinasi dengan Komite Farmasi dan Terapi terkait manajemen risiko di RS yang berhubungan dengan pemberian farmasi dan terapi
- i. Seluruh unit/instalasi di RS
1. Tata hubungan kerja dalam penerapan peningkatan mutu RS
Komite Mutu berkoordinasi dengan kepala unit atau instalasi terkait dengan peningkatan mutu, termasuk penentuan indikator mutu unit, pengumpulan, analisa, tindak lanjut, dan pelaporan indikator nasional mutu RS, indikator mutu prioritas RS, indikator mutu prioritas unit dan indikator mutu lain, serta analisa dan tindak lanjut dari indikator mutu yang belum sesuai dengan standar.



- j. Tata hubungan kerja dalam penerapan keselamatan pasien
Komite Mutu berkoordinasi dengan kepala unit atau instalasi dan seluruh staf terkait dengan insiden keselamatan pasien yang dilaporkan, serta melakukan pembahasan bersama kepala unit atau instalasi terkait dengan investigasi, baik investigasi sederhana maupun investigasi komprehensif (RCA)
- k. Tata hubungan kerja dalam penerapan manajemen risiko
Komite Mutu berkoordinasi dengan kepala unit atau instalasi dan seluruh staf terkait dengan manajemen risiko di Rumah Sakit, mulai dari identifikasi risiko hingga penanganan risiko.



BAB III ISI PEDOMAN

3.1 Umum

Pedoman kerja Komite PMKP merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Pedoman ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar akreditasi rumah sakit, guna menjamin pelayanan yang aman, bermutu, efektif, dan berorientasi pada pasien.

3.2 Dasar Hukum dan Acuan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Tranfusi Darah ;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 25 tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 773.145/I-KEP/DIR/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;
9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 200.50/DPM/I-KEP/DIR/II/2022 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada;

3.3 Tujuan Pedoman Kerja

1. Menjadi acuan pelaksanaan program PMKP di rumah sakit
2. Menjamin konsistensi pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien
3. Mendukung pemenuhan standar akreditasi rumah sakit
4. Meningkatkan budaya keselamatan pasien di seluruh unit kerja

3.4 Ruang Lingkup

Pedoman kerja ini mencakup seluruh kegiatan PMKP di rumah sakit, meliputi:

1. Perencanaan program PMKP
2. Pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu
3. Pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien
4. Monitoring dan evaluasi indikator mutu
5. Edukasi dan pelatihan PMKP
6. Implementasi budaya keselamatan pasien

3.5 Mekanisme Kerja

- a) Perencanaan
 - Menyusun program kerja tahunan PMKP
 - Menetapkan indikator mutu prioritas
 - Menentukan target capaian
- b) Pelaksanaan
 - Pengumpulan data indikator mutu



- Pelaksanaan perbaikan mutu (PDCA/PDSA)
- Pelaporan insiden keselamatan pasien
- c) Monitoring dan Evaluasi
 - Monitoring capaian indikator
 - Analisis tren data
 - Evaluasi program
- d) Pelaporan
 - Laporan rutin kepada direktur
 - Pelaporan insiden
 - Dokumentasi kegiatan

3.6 Indikator Mutu dan Keselamatan Pasien

1. Indikator Nasional Mutu (INM)
2. Indikator mutu prioritas rumah sakit
3. Indikator mutu unit kerja
4. Indikator keselamatan pasien

3.8 Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien

1. Identifikasi risiko
2. Pelaporan insiden
3. Analisis akar masalah (RCA)
4. Tindak lanjut

3.9 Edukasi dan Budaya Mutu

1. Sosialisasi PMKP
2. Pelatihan keselamatan pasien
3. Kampanye budaya keselamatan
4. Peningkatan kepatuhan

3.10 Dokumentasi dan Bukti Kegiatan

1. Program kerja
2. Data indikator
3. Laporan insiden
4. Notulen rapat
5. Laporan evaluasi

3.11 Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

1. Evaluasi berkala
2. Revisi pedoman
3. Continuous Quality Improvement

Malang, 03 Januari 2026

PLT Direktur RS Prima Husada Malang,



dr. Resti Lestantini, M. Kes